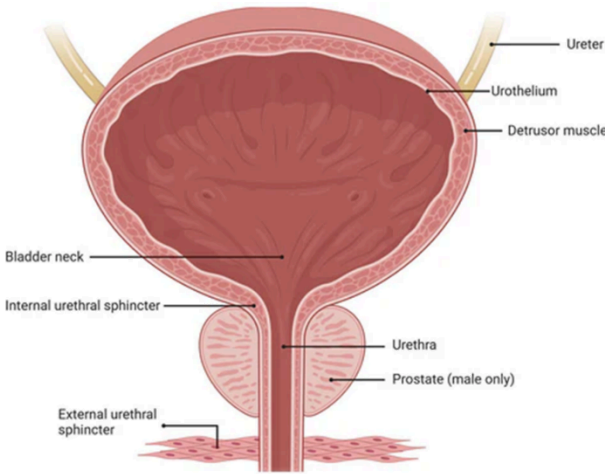
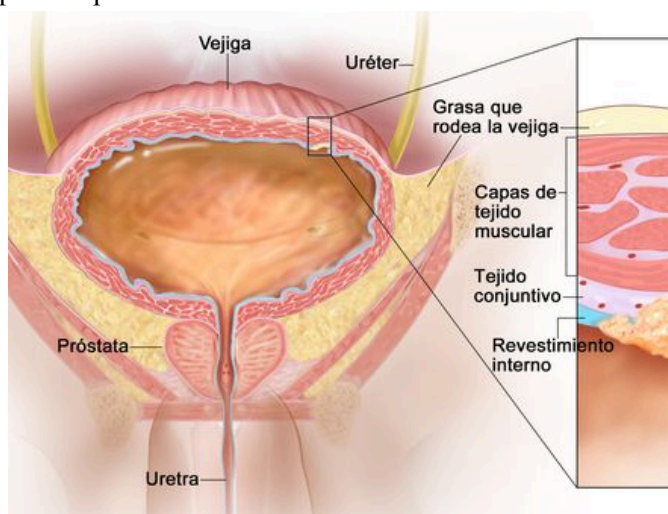




NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: <i>CISTECTOMÍA PARCIAL</i>			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
• ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. OBJETIVO QUIRÚRGICO: (HACER DESCRIPCIÓN) Procedimiento mediante el cual se extirpa parte de la vejiga y se reconstruye de nuevo, preservando la integridad vesical como reservorio de la orina.			
1.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: (HACER GRÁFICO Y DESCRIPCIÓN). ANATOMÍA  La vejiga es un órgano muscular hueco y distensible, situado en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres, se encuentra por delante del recto y en la mujer es anterior a la vagina e inferior al útero. Con una capacidad de la vejiga oscila en promedio entre 700 y 800 ML. La vejiga posee 3 porciones:			

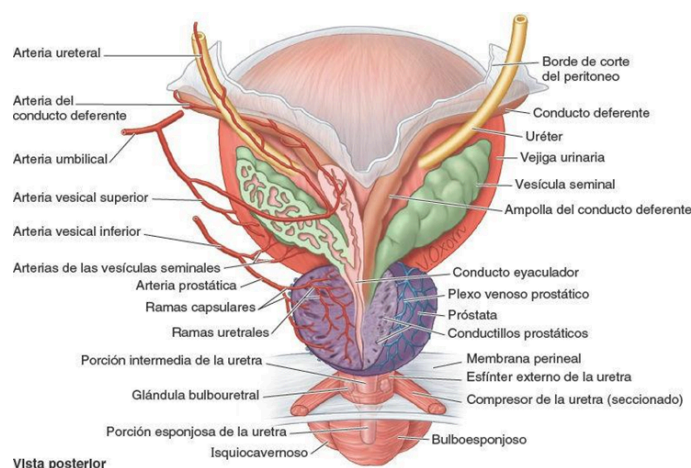
- o **Cuerpo:** Dónde la orina es recolectada.
- o **Fondo (Base):** Contiene al trigono vesical.
- o **Trígono Vesical:** Donde se localiza la uretra.

A su vez se compone por 3 capas:



- **Capa Serosa:** Se compone de tejido conectivo alveolar.
- **Capa Muscular:** Formada por 3 capas de fibras musculares lisas: Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa.
- **Capa Mucosa:** Compuesta por epitelio de transición y una lámina propia subyacente.

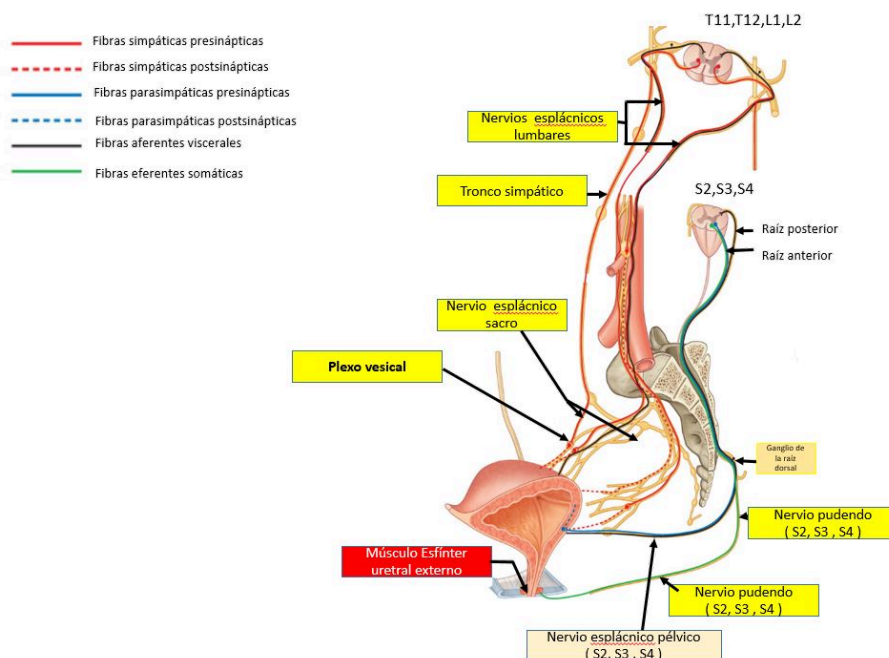
IRRIGACIÓN.



Es drenada por las **venas ilíacas internas**, y tanto en hombres como en mujeres, los vasos linfáticos de las caras supero laterales de la vejiga desembocan en los **ganglios linfáticos ilíacos externos**

INERVACION

Involucra el sistema nervioso simpático y parasimpático



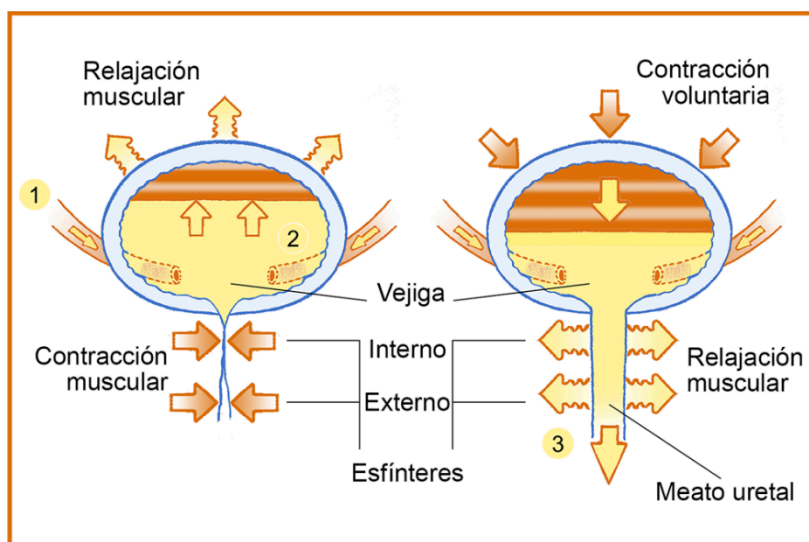
1. Las fibras simpáticas presinápticas para la vejiga urinaria son conducidas desde los niveles torácicos inferiores y lumbares superiores de la médula espinal a través de los nervios espláncnicos lumbares pasando por el tronco simpático lumbar, plexo hipogástrico superior y nervios hipogástricos hacia los plexos vesicales (pélvicos). Es un subplexo del plexo hipogástrico inferior, de ahí envían fibras autónomas postsinápticas a las paredes de la vejiga urinaria.
2. Las fibras parasimpáticas presinápticas para la vejiga urinaria se originan en las neuronas de los segmentos sacros de la médula espinal S2-S4 y pasan desde los ramos anteriores de los nervios espinales sacros, a través de los nervios espláncnicos pélvicos y los plexos hipogástricos inferiores, hasta la vejiga urinaria.

RELACIONES DE LA VEJIGA:

- **PARTE ANTERIOR:**
 - Sínfisis del pubis
 - Espacio prevesical de Retzius.
 - Músculos de la pared abdominal
 - Fascia umbilicoprevesical
 - Uraco

- Vasos umbilicales obliterados
- **PARTE INFERIOR:**
 - Músculo elevador del ano
 - Músculos internos de la pelvis
- **PARTE POSTERIOR:**
 - Tiene el fondo de saco vésico rectal de Douglas y la Ampolla rectal.
- **PARTE SUPERIOR:**
 - Uréteres, Conductos Deferentes y Vesículas Seminales.

FISIOLOGIA



Los músculos de la vejiga que permiten el control voluntario de la micción y permiten 2 funciones: 1) la sensación que permite que reconozcas que tu vejiga está llena y debe ser vaciada y 2) el control motor que permite que puedas orinar voluntariamente.

Primero, como la pared vesical se estira cuando está llena o próxima a su máxima capacidad, existen señales que son transmitidas a través del sistema nervioso parasimpático para contraer el músculo detrusor, el cual es una capa de la pared vesical constituida por fibras de músculo liso que son ordenadas en fascículos longitudinales, circulares o en espiral, esta señal estimulará a la vejiga para expulsar orina a través de la uretra, luego, estas sensaciones dentro de la vejiga serán transmitidas al sistema nervioso central (SNC) por medio de fibras aferentes viscerales generales (AVG). Mientras las fibras aferentes en la cara superior de la vejiga siguen el curso de los nervios simpáticos eferentes hasta el SNC, las fibras aferentes en la porción inferior siguen a las fibras parasimpáticas eferentes.

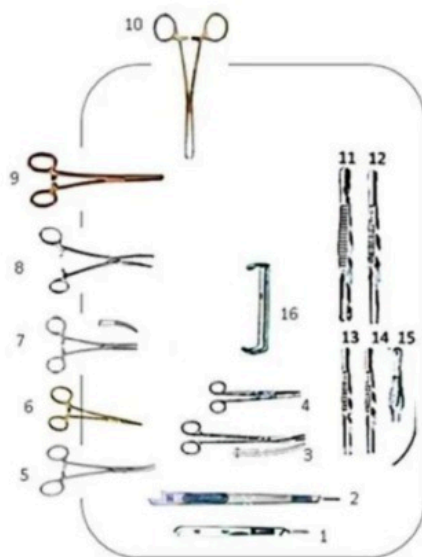


1.3. LISTA DE CHEQUEO:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
Equipo de general Equipo vascular Clamps Intestinales	- Paquete de ropa - Sonda Foley 22 x 30 - Jeringa de 20 cc - Gasas - Caucho de succión - Asepto jeringa - Torundas - Hoja de bisturí #15- #20 - Lapicero de electrobisturí - Guantes - Cistofló - Equipo de venoclisis - Sonda nelaton	PIEL: Polipropileno 3/0 aguja curva cortante 3/8 de círculo. TCS: Catgut cromado 3/0 aguja redonda medio círculo. FASCIA: Poliglactin 0 o 1 aguja curva redonda de ½ de círculo. Seda 2/0 o 3/0 precortadas. Poliglactina 910 3/0 para anastomosis.	Solución salina

• **ETAPA DE ORGANIZACIÓN:**

o **ARREGLOS DE MESAS DE MAYO Y RESERVA (REALIZAR ESQUEMA).**



1. Mango de bisturí 4 hoja 20
2. Mango de bisturí 3 hoja 15
3. Tijera de Metzembaum
4. Tijera de mayo recta
5. Pinza Kelly curva
6. Pinza Kelly recta
7. Pinza Kelly Adson
8. Pinza Rochester curva
9. Pinza Rochester recta
10. Pinza Allis
11. Pinza disección rusa
12. Pinza disección sin garra larga
13. Pinza disección con garra corta
14. Pinza disección sin garra corta
15. Pinza disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf

1. Equipo general
2. Coca
3. Valva maleable
4. Deaver angosto
5. Coca con suero
6. Cánula de yankawer
7. Porta aguja
8. Sutura
9. Tijera de Metzenbaum fina
10. Tijera de mayo larga
11. Pinza de Foerster
12. Pinza de campo Backhouse
13. Compresas
14. Lápiz de electrobisturí
15. Paquete de ropa
16. Guantes
17. Caucho de succión
18. Frascos de patología





2.2. POSICIÓN DEL PACIENTE (NOMBRE Y GRÁFICO):

Decúbito supino con un ligero Trendelenburg



2.3. UBICACIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO (REALIZAR GRÁFICO):

Izquierda



Derecha

- **ETAPA DE EJECUCION:**

- **ANESTESIA (ESCRIBIR EL TIPO DE ANESTESIA):** Anestesia general o raquídea





- **INCISIÓN (ESCRIBIR EL TIPO DE ABORDAJE Y EL NOMBRE DE LA INCISIÓN):**

Abordaje: El abordaje puede ser abierto o mínimamente invasivo para extirpar un tumor vesical, dejando un margen de seguridad de aproximadamente y incisión de Pfannenstiel

- **PROCESO QUIRÚRGICO (DESCRIBIR LOS PASOS PRINCIPALES DE LA TÉCNICA MÉDICO QUIRÚRGICA CON EL INSTRUMENTAL A USAR).**

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Incisión en línea media desde la sínfisis del pubis hasta la proximidad del ombligo	mango de bisturí 3 hoja de bisturí 15
Se incide la fascia muscular del recto verticalmente	Tijera de Mayo
Para ello se abre el peritoneo próximo al ombligo, en dirección vertical.	Electrobisturí
Se colocan dos suturas de referencia sobre la pared vesical alejadas de la localización del tumor.	Suturas



Se aísla la vejiga de los bordes de la herida mediante cubiertas plásticas para reducir el riesgo de un implante tumoral.	Cubiertas plásticas estériles
Se abre la vejiga entre las suturas mediante una incisión longitudinal	Electrobisturí Allix
Se localiza el tumor en la mucosa vesical	
Se realiza una incisión circunferencial alrededor de él, con un margen de seguridad no inferior a 2 cm y abarcando la totalidad del espesor de la pared vesical	Mango de bisturí 4
Si el tumor está a menos de 2 cm del meato ureteral, se reseca el mismo y se procede a realizar un reimplante con cateterización del mismo.	
Se cierra la vejiga en dos planos; mucosa y la capa sero-muscular	ác. poliglicólico (DEXON®) de 4/0, 5/0 y 3/0
Se coloca una sonda uretral de 20 F y un drenaje perivesical.	Sonda Ureteral
FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA IQX-FT-024-UDES	



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

**PLANEAMIENTO QUIRURGICO PRACTICA
FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC**

Versión: 01